

Composition:

Each ATORVA (10-20-40) Film Coated Tablet contains:

Atorvastatin (as Calcium Trihydrate) 10 - 20 - 40 mg.

Mechanism of Action:

Atorvastatin is a selective and competitive inhibitor of HMG-CoA reductase, this limits the action of the enzyme that converts HMG-CoA into mevalonate, which is a precursor to synthesis of sterols including cholesterol. Inhibition of this enzyme reduces the amount of mevalonate and thus reduces cholesterol levels in hepatocytes.

Atorvastatin is effective in reducing LDL cholesterol in patients with homozygous familial hypercholesterolemia, a group that does not usually respond to other lipid-lowering drugs. Reductions in total cholesterol, LDL cholesterol and apolipoprotein B have been shown to reduce the risk of cardiovascular disease and death from it.

Pharmacokinetics:

Atorvastatin is rapidly absorbed after oral administration; maximum plasma concentrations (C_{max}) occur within 1 to 2 hours. The absolute bioavailability of atorvastatin is approximately 12% and the systemic availability of HMG-CoA reductase inhibitory activity is approximately 30%. Atorvastatin is eliminated primarily in bile following hepatic and/or extrahepatic metabolism. Mean plasma elimination half-life of atorvastatin in humans is approximately 14 hours. The half-life of inhibitory activity for HMG-CoA reductase is approximately 20 to 30 hours due to the contribution of active metabolites.

Indications:

Hypercholesterolemia:

ATORVA is indicated as an adjunct to diet for reduction of elevated total cholesterol (total-C), LDL-cholesterol (LDL-C), apolipoprotein B, and triglycerides in adults, adolescents and children aged 10 years or older with primary hypercholesterolaemia including familial hypercholesterolaemia (heterozygous variant) or combined (mixed) hyperlipidaemia (corresponding to Types IIa and IIb of the Fredrickson classification) when response to diet and other nonpharmacological measures is inadequate. ATORVA is also indicated to reduce total-C and LDL-C in adults with homozygous familial hypercholesterolaemia as an adjunct to other lipid-lowering treatments or if such treatments are unavailable.

Prevention of cardiovascular disease:

ATORVA used to prevention of cardiovascular events in adult patients estimated to have a high risk for a first cardiovascular event, as an adjunct to correction of other risk factors.

Contraindications:

ATORVA is contraindicated in the following cases:

- Hypersensitivity to the active substance or any of the components of the preparation.
- Patients with active liver disease or in case of unexplained persistent elevation of transaminase enzymes in the blood that exceeds 3 times the upper limit of normal.

- During pregnancy and breastfeeding and in women who are likely to bear children, or who are not using appropriate contraceptive methods.
- Patients with hepatitis C who are being treated with glecaprevir/pibrentasvir.

Warnings & Precautions:

- Hepatic Effects: Liver function tests should be performed for patients who show any signs or symptoms suggestive of liver injury. ATORVA should be used with caution in patients with pre-existing liver problems.
- Musculoskeletal effects: There have been very rare reports of IMT-mediated myopathy during or after treatment with some statins.
- Before treatment: creatine kinase levels should be measured before starting treatment with statins if: renal impairment, hypothyroidism, family history of hereditary muscle disorders, previous history of muscle toxicity with statin use, previous history of liver disease, in the elderly (over 70 years of age) The necessity of such a measurement should be taken into account, due to the presence of other predisposing factors for rhabdomyolysis.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy category X. ATORVA should not be used in women who are pregnant, or suspect they are pregnant. ATORVA may cause fetal harm when administered to a pregnant woman.

Lactation: It is unknown whether atorvastatin or its metabolites are excreted in human milk. Atorvastatin is contraindicated during breast-feeding.

Drug Interactions:

CYP3A4 Inhibitors: Strong CYP3A4 inhibitors such as cyclosporine, clarithromycin, ketoconazole, itraconazole, and some antivirals such as grazoprevir and elbasvir have been shown to significantly increase the concentration of atorvastatin in the blood. The concomitant use of atorvastatin with these drugs should be avoided due to the increased risk of myopathy.

Inducers CYP3A4: Coadministration of atorvastatin with cytochrome P450 3A4 inducers (eg, efavirenz, rifampin) can lead to variable decreases in plasma concentrations of atorvastatin.

Transporter Inhibitors: Transporter inhibitors (eg, ciclosporin, letermovir) can increase the plasma concentration of atorvastatin.

Ezetimibe, Fusidic Acid (systemic) and Colchicine: Concomitant use of these drugs with ATORVA may increase the risk of rhabdomyolysis.

Digoxin: Patients receiving digoxin should be monitored for increased steady-state concentrations of digoxin with concomitant administration of atorvastatin.

Oral Contraceptives: Concomitant use of atorvastatin with oral contraceptives causes an increase in plasma concentrations of norethindrone and ethinyl estradiol.

Side Effects:

Common: Allergic reactions, hyperglycemia, nasopharyngitis, blood and lymphatic system disorders, pharyngeal and laryngeal pain, epistaxis, gastrointestinal disturbances, constipation, flatulence, dyspepsia, nausea, diarrhoea.

Uncommon and Rare: Loss of appetite, weight gain, dizziness or numbness, blurred vision, cholestasis.

Driving & Using Machines:

ATORVA does not affect the ability to drive or operate machinery. However, do not perform any activities if this medicine affects your ability to drive or operate machinery.

Dosage & Administration:

The patient should be placed on an appropriate cholesterol-lowering diet before using ATORVA and this diet should be continued during treatment with ATORVA.

ATORVA can be taken with or without food.

Primary hypercholesterolemia and mixed hyperlipidemia:

Blood cholesterol is controlled in the majority of patients with ATORVA 10 mg once a day. A therapeutic response appears within 2 weeks, and a maximum therapeutic response is usually achieved within 4 weeks.

Various familial hypercholesterolemia:

Patients should begin taking ATORVA 10 mg daily. The dose should be adjusted to the need of each patient every 4 weeks, up to 40 mg daily. Subsequently, the dose may be increased to a maximum of 80 mg per day or the bile acid-binding resins may be taken with Atorva 40 mg once daily.

Homozygous familial hypercholesterolemia:

The dose of ATORVA is 10 to 80 mg daily. ATORVA should be used as an adjunct to other lipid-lowering treatments in these patients or if these treatments are not appropriate.

Prevention of cardiovascular disease:

In primary prevention trials the dose was 10 mg per day. Higher doses may be necessary in order to reach appropriate levels of LDL cholesterol according to guidelines.

Renal impairment: No dose adjustment is required.

- If you miss a dose:

1. Within less than 12 hours: Patients should take the dose immediately and then take the next dose at the usual time.
2. For more than 12 hours: Patients should take the next dose at the usual time and not take a double dose.

Overdose:

No specific treatment is available in case of an overdose of atorvastatin. In the event of an overdose, the patient should be treated symptomatically and supportive measures taken as needed. Liver function tests should also be performed and creatinine kinase levels monitored in the blood.

Storage:

Keep this medicine out of reach of children. Store below 30 °C.

Packaging:

Each ATORVA carton box contains 20 Film Coated Tablets in two Alu/Alu Strips.

كل مضغوطة أتورفا (١٠-٢٠-٤٠) ملبسة بالفيلم تحتوي على:
 أتورفاستاتين (على شكل كالسيوم تري هيدرات) ١٠-٢٠-٤٠ ملغ.

أتورفاستاتين وهو مثبط انتقائي وتنافسي للإنزيم HMG-CoA reductase، وهذا ما يحد من عمل الإنزيم الذي يحول HMG-CoA إلى ميفالونات، التي تعتبر مقدمة لاصطناع الستيرولات بما في ذلك الكوليسترول. حيث أن تثبيط هذا الإنزيم يقلل من كمية الميفالونات وبالتالي يقلل من مستويات الكوليسترول في الخلايا الكبدية.

أثورة فاساتين فعال في تقليل الكوليسترول منخفض الكثافة في المرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي المتماثل الواجه، وهي مجموعة لا تستجيب عادةً للأدوية الأخرى الخافضة للدهون. ثبت أن الانخفاض إجمالي الكوليسترول والكثافة والكوليسترول البروتيني الشحمي B يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، الأوعية الدموية، وهف الناجمة عنها.

يُخصّص أئورفاستاتين بسرعة بعد تناوله عن طريق الفم، ويصل إلى التراكيز البلازمية العظمى (Cmax) في غضون ٢-١ ساعة. يبلغ التوافر الجيوي المطلق لأئورفاستاتين حوالي ١٢ ٪. والتوافر الجهازي لنشطاء تثبيط أنزيم HMG-CoA reductase حوالي ٣٠ ٪. يتم إخراج الأئورفاستاتين في الدرجة الأولى عند طريق الصفراء بعد الاستقلاب الكبدي و/ أو خارج الكبدي. يبلغ متوسط العمر النصفى لإطراح الأئورفاستاتين لدى البشر حوالي ١٤ ساعة. كما يبلغ العمر النصفى لتأثيره المثبط لأنزيم HMG-CoA reductase حوالي ٢٠ إلى ٣٠ ساعة بسبب مهاجمة مثبطاته للنشطة.

فرط كوليسترول الدم:

يستعمل أتورفا كعامل مساعد للحمية الغذائية لتقليل الكوليسترول الكلي والمترفع، والكوليستيرول منخفض الكثافة، والبروتين الشحمي B، والشحم عند البالغين والمرافقين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٠ سنوات أو أكثر مع ارتفاع الكوليستيرول الأولي بما في ذلك فرط كوليستيرول الدم العائلي (متغير الواصل) أو فرط شحميات الدم المختلط (المقابل للنوعين IIa و IIb) من تصنيف فريديكسون) عندما تكون الاستجابة للنظام الغذائي والتدابير غير الدوائية الأخرى غير كافية.

يستطاع أتورفا أيضاً لخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول منخفض الكثافة لدى البالغين المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي متمثل اللواقح وذلك كعلاج مساعد لخفضات الشحوم الأخرى أو في حال عدم توفر هذه العلاجات.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:
يستعمل أتورفا للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية في الأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية للإصابة بأمراض قلبية وعائية لأول مرة وذلك كعلاج مساعد لضبط عوامل الخطر الأخرى.

مضادات الاستطباب:
إن أتورفا مضاد استطباب في الحالات التالية:
- فرط الحساسية للمادة الفعالة أو أي من مكونات المستحضر.
- المرضى الذين يعانون من أمراض كبدية نشطة أو في حال الارتفاع المستمر

غير المبرر لإنزيمات الترانس أميناز في الدم والتي تتجاوز ٣ أضعاف الحد الأعلى للطبيعي.

• أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية وعند النساء اللواتي من المحتمل حدوث حمل لديهن، أو اللواتي لا يستخدمن وسائل منع حمل مناسبة.

مرضى التهاب الكبد الوبائي C الذين يعانون بـ غليكابريفير وببيرينتاسفير.

تأثيرات كبدية: يجب إجراء اختبارات وظائف الكبد للمرضى الذين تظهر عليهم أي علامات أو أعراض توحى بإصابة الكبد. يجب استخدام أتورفا بحذر لدى المرضى الذين لديهم مشاكل كبدية سابقة.

تأثيرات عضلية هيكلية: هناك تقارير نادرة جداً عن اعتلال عضلي ناتج عن انخر المتوسط منعياً أثناء أو بعد المعالجة ببعض الستاتينات.

قبل العلاج: يجب قياس مستويات الكراتينين كيناز قبل بدء المعالجة بالاستاتينات في حال: القصور الكلوي، قصور الغدة الدرقية، تاريخ عائلي لاضطرابات العضلات الوراثية، تاريخ سابق لاضطراب استخدام الاستاتينات، تاريخ سابق لأمراض الكبد، عند كبار السن (أعلى من ٧٠ سنة) يجب مراعاة ضعف وظائف الكلى، يجب عدم عمل اختبار مية متلازمة انحلال الدم البولي.

لحملة: الفئة الحملية X. ينبغي عدم استخدام أتورفا لدى النساء الحوامل أو لمشيته في أنهن حوامل. فقد يسبب أتورفا ضرراً للجنين عند إعطائه للمرأة الحامل.

الإرضاع: من غير المعروف ما إذا كان أتورفاستاتين ومستقلباته تفرز في حليب الأم. يمنع استخدام أتورفاستاتين أثناء الرضاعة الطبيعية.

يُثبِت أنزيمات السيروتكروم (CYP3A4): ثبت أن مثبطات CYP3A4 القوية مثل السيكلوسبورين، وكابتازين، وفامبين، والكلينوكينول، وإيزونيازول، يثبِطن المصادات الفيرومات مثل غرازوفيريقر، وإيلياسفير، تؤدي إلى زيادة تركيز أتورفاستاتين في الدم بشكل ملحوظ، يجب تجنب الاستعمال المتزامن لأتورفاستاتين مع هذه الأدوية بسبب زيادة خطر حدوث الاعتلال العضلي. محفزات أنزيمات السيروتكروم (CYP3A4): إن الاستعمال المتزامن لأتورفاستاتين مع محفزات السيروتكروم CYP3A4 (مثل إيفافيرينز، ريفامبين) يمكن أن تؤدي إلى انخفاضات متفجرة في تركيز أتورفاستاتين البلازمية.

شبّطات النواقل: يمكن لمثبطات بروتينات النقل (مثل سيكلوسبورين
لتنبر موفر) أن تزيد من التركيز البلازما للأدوية الفاستاتين.

يزيتيميب وحمض الفوسيديك (جهازى) والكولشيسين: إن الاستعمال المتزامن لهذه الأدوية مع أتورفا يمكن أن يزيد من خطر انحلال الربيدات.

الديجوكسين: يجب مراقبة المرضى الذين يتناولون الديجوكسين بسبب زيادة تراكيز الديجوكسين في الحالة المستقرة عند الاستخدام المتزامن مع ثورفاستاتين.

مانعات الحمل الفموية: الاستعمال المتزامن للأتورفاستاتين مع مانعات الحمل الفموية يسبب زيادة في التراكيز البلازمية لـ نورثيندرون وإثنيل استراديول.

بناحية: ردود فعل تحسسية، ارتفاع السكر في الدم، التهاب البلعوم الأنفي، اضطرابات الدم والجهاز الليمفاوي، ألم البلعوم والحنجرة، رعاف، اضطرابات الجهاز الهضمي، إمساك، انتفاخ البطن، عسر هضم، غثيان، إسهال. غير شائعة ونادرة: فقدان الشهية، زيادة الوزن، دوار أو تقيؤ، عدم وضوح الرؤية، ركود صفراوي.

أنتورفا لا يؤثر على المقدرة على القيادة أو تشغيل الآلات. ومع ذلك، لا تقم بأي نشاطات إذا كان هذا الدواء يؤثر على قدرتك على القيادة أو تشغيل الآلات.

يجب وضع المريض على حمية غذائية مناسبة لخفض الكوليسترول قبل استعمال أتورفا ويجب أن تستمر هذه الحمية أثناء العلاج بأتورفا. يمكن تناول أتورفا مع أو بدون طعام.

فقرط كولسترول الدم الأولي وفقرط شحميات الدم المختلط:
يتم ضبط كولسترول الدم عند غالبية المرضى باستعمال أتورفا ١٠ ملغ مرة واحدة في اليوم. تظهر الاستجابة العلاجية في غضون أسبوعين، وعادةً ما يتم تحقيق أقصى استجابة علاجية في غضون ٤ أسابيع.

فرط كوليسترول الدم العائلي **مختلف الواقع:**
يجب أن يبدأ المرضى باستعمال أتورفا ١٠ ملغ يومياً. يجب ضبط الجرعة حسب حاجة كل مريض كل ٤ أسابيع حتى الوصول إلى ٤٠ ملغ يومياً. بعد ذلك، يمكن زيادة الجرعة إلى ٨٠ ملغ يومياً كحد أقصى أو يمكن تناول الـ ٨٠ ملغ بنيت الـ ١٤ مرة للحمض الصفراء، مع أتورفا ٤٠ ملغ مرة واحدة يومياً.

فرط كوليسترول الدم العائلي متمثل بالوفاة:

جرعة أتورفا هي ١٠ إلى ٨٠ ملغ يوميا. يجب استخدام أتورفا كعامل مساعد للعلاجات الأخرى لخفض الشحوم في هؤلاء المرضى أو في حال كانت هذه العلاجات غير مناسبة.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:
 في تجارب الوقاية الأولية كانت الجرعة ١٠ ملغ في اليوم. قد يكون من الضروري تناول جرعات أعلى من أجل الوصول إلى مستويات مناسبة للكوليسترول وفقاً للمبادئ التوجيهية.

القصور الكلوي: لا يلزم تعديل الجرعة.

١. في غضون أقل من ١٢ ساعة: يجب على المرضى تناول الجرعة على الفور ثم تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد.

٢. لأكثر من ١٢ ساعة: يجب على المرضى تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد وعدم أخذ جرعة مضاعفة.

لا يتوفر علاج محدد في حال تناول جرعة زائدة من أتورفاستاتين. في حالة

تتناول جرعة زائدة، يجب معالجة المريض معالجة عرضية وإجراء تدابير داعمة عند الحاجة. كما يجب إجراء اختبارات وظائف الكبد ومراقبة مستويات كراتينين كيناز الدموية.

احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، يحفظ بدرجة حرارة أقل من ٣٠°م.

التعبئة:
 لكل عبوة كرتونية أنورفا تحتوي على ٢٠ مضغوبة ملبسة بالفيلم ضمن
 شربطين Alu/Alu.

مستحضر يؤثر على صحته واستعماله خلافاً للتعليمات بحضرك للخطر
وصحة الطبيب، وطريقة الاستعمال الموصى بها وتعليمات الصيدلي
سرفها لك، والطبيب والصيدلي هما اللذان يقران في الدواء وينفعه ويضره.
لا تأكل من الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية بمفردها بأيدي الأطفال.
مجلس وزراء الصحة وزعم واتحاد الصيادلة العرب.